

GNRP — EMERGÊNCIA NEFROLÓGICA

FLUXOGRAMA — SUSPEITA À CONDUTA

GNRP — RIM EM SEMANAS, AGIR RÁPIDO

Síndrome nefrítica + queda $\geq 50\%$ da função renal em dias a semanas (rins de tamanho normal)

INTERNAR + screening etiológico + BIÓPSIA renal

Pulsoterapia com corticoide (mesmo antes da biópsia) +/- ciclofosfamida + plasmaferese

Hemorragia alveolar = síndrome pulmão-rim

DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

O QUE É

- Síndrome de piora $\geq 50\%$ da função renal em dias a semanas (< 3 meses)
- Histologia clássica: CRESCENTES glomerulares
- 3 grupos etiológicos: anti-MBG (Goodpasture); imunocomplexos (LES, nefropatia por IgA); pauci-imune (vasculites ANCA, ex.: granulomatose com poliangeíte)
- Pode evoluir com hemorragia alveolar = SÍNDROME PULMÃO-RIM

QUANDO SUSPEITAR

QUADRO NEFRÍTICO + PERDA RÁPIDA DE FUNÇÃO

- Hematúria (dismorfismo eritrocitário / CILINDROS HEMÁTICOS) + proteinúria subnefrótica (1-3 g/24h)
- Oligúria ($> 50\%$ dos casos; associada a pior prognóstico), HAS, edema
- Em adultos costuma ser subaguda: astenia, inapetência, febre baixa
- Sintomas sistêmicos de vasculite: artralgia, rash/púrpura, epístaxe/sinusite, neuropatia
- Pulmonar: hemoptise/dispneia $\rightarrow$ síndrome pulmão-rim (Goodpasture ou vasculite ANCA)

EXAMES

FUNÇÃO + ETIOLOGIA + BIÓPSIA

- Função/urgência: hemograma, ureia, creatinina, eletrólitos, gasometria
- Urina I (hematúria dismórfica/cilindros), proteinúria 24h ou relação P/C
- Etiologia: FAN, anti-DNA, COMPLEMENTO (C3/C4), ANCA, anti-MBG, PCR
- sorologias HIV/sífilis/hepatites B e C; conforme suspeita: crioglobulinas, eletroforese
- USG: rins de TAMANHO NORMAL com IRA reforçam a suspeita de GNRP
- BIÓPSIA RENAL: todo paciente com suspeita deve biopsiar (diagnóstico + prognóstico + guia do imunossupressor)

TRATAMENTO

Rx PULSOTERAPIA + IMUNOSSUPRESSÃO

Na SUSPEITA, mesmo antes da confirmação, considerar PULSOTERAPIA com corticoide
Metilprednisolona 10-15 mg/kg/dia (até ~1 g/dia) por até 3 dias
diluir em 150-200 mL de SG 5%, infusão LENTA EV em 2-3h (menor repercussão hemodinâmica)
Ciclofosfamida conforme etiologia (anti-MBG, vasculite ANCA, nefrite lúpica) — esquema pela doença de base
PLASMAFÉRESE em casos específicos (doença anti-MBG; hemorragia alveolar)
Doença que EXIGE acompanhamento do nefrologista — não conduzir isolado

RED FLAGS — EMERGÊNCIA

INTERNAR IMEDIATAMENTE

- Toda suspeita de GNRP = internação hospitalar imediata
- Avaliar urgências dialíticas (hipercalcemia, acidose, sobrecarga, uremia)
- Hemorragia alveolar (hemoptise, queda de Hb, infiltrado) = síndrome pulmão-rim, risco de vida
- Definir etiologia rapidamente (guia o tratamento) — não atrasar a pulsoterapia na forte suspeita
- Oligúria/anúria = forte associação com evolução para doença renal terminal

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ Reconhecer a síndrome nefrítica com perda acelerada de função (creatinina seriada)
- ☐ Colher screening etiológico ANTES da imunossupressão (FAN, ANCA, anti-MBG, complemento, sorologias)
- ☐ Avaliar e tratar urgências dialíticas
- ☐ Acionar nefrologia para biópsia e definição terapêutica; considerar pulsoterapia na forte suspeita
- ☐ Buscar e tratar hemorragia alveolar (síndrome pulmão-rim)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Síndrome nefrítica com perda acelerada de função (suspeita de GNRP). Creatinina atual ____ (prévia ____).
- EAS: hematúria dismórfica / cilindros hemáticos / proteinúria. Débito: oligúrico? Achados extrarrenais: ____ (hemoptise?).
- USG: rins de tamanho preservado. Necessidade de diálise: sim/não.
- Solicito transferência URGENTE para biópsia renal e início de pulsoterapia/plasmaférese (nefrologia).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente com hematúria, cilindros hemáticos, creatinina subindo de 1,0 para 4,0 em 3 semanas e rins de tamanho normal ao USG. Qual a hipótese e conduta?

- A) Doença renal crônica terminal — diálise eletiva
- B) GNRP — internação imediata, screening etiológico, biópsia renal e considerar pulsoterapia com corticoide
- C) Infecção urinária — antibiótico oral
- D) Nefrolitíase — analgesia e alta
- E) Síndrome nefrótica — corticoide ambulatorial

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado histopatológico é clássico da GNRP?

- A) Esclerose glomerular difusa
- B) Crescentes glomerulares
- C) Depósitos de amiloide
- D) Membrana basal espessada isolada
- E) Necrose tubular aguda

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

A associação de GNRP com hemorragia alveolar caracteriza qual quadro?

- A) Síndrome nefrótica
- B) Síndrome pulmão-rim
- C) Síndrome hepatorenal
- D) Síndrome de lise tumoral
- E) Síndrome cardiorrenal

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual exame é mandatório na investigação da GNRP (diagnóstico e prognóstico)?

- A) Urocultura
- B) Biópsia renal
- C) Radiografia de abdome
- D) Cintilografia renal
- E) Cistoscopia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o tratamento da GNRP na forte suspeita clínica, é correto:

- A) Aguardar sempre a biópsia antes de qualquer tratamento
- B) Considerar pulsoterapia com corticoide mesmo antes da confirmação, com acompanhamento do nefrologista
- C) Iniciar antibiótico empírico de amplo espectro
- D) Apenas hidratação e observação
- E) Diálise eletiva ambulatorial

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Síndrome nefrítica com queda rápida da função renal (>50% em semanas) e rins de tamanho normal define GNRP — emergência. Conduta: internar, colher screening etiológico, biopsiar e considerar pulsoterapia com corticoide.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

As crescentes glomerulares são o achado histopatológico clássico da GNRP, refletindo proliferação extracapilar por ruptura da parede do capilar glomerular.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

GNRP + hemorragia alveolar (hemoptise) caracteriza a síndrome pulmão-rim, vista na doença anti-MBG (Goodpasture) e em vasculites ANCA — quadro grave, com risco de vida.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A biópsia renal é mandatória na GNRP: define o padrão (anti-MBG, imunocomplexos, pauci-imune), o prognóstico e guia a escolha do imunossupressor e terapias adjuvantes.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Na forte suspeita de GNRP, considera-se a pulsoterapia com corticoide mesmo antes da confirmação histológica, dado o risco de perda renal irreversível, sempre com acompanhamento do nefrologista.

SM24
Suporte ao Plantão Médico